EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 82525
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-04-15 12:19:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MANUEL JESUS ARAVENA GAVILAN			RUN	: 6.869.845-6
F.Nac	: 16-11-1952	Edad	: 71 AÑOS, 4 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: A. PRAT 478			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 86561157		
Fecha Ingreso	: 2024-04-04	Fecha Egreso	: 2024-04-15 12:19:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J47.X-BRONQUIECTASIA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) Neumonia lobulo superior izquierdo (bronquiectasia asociada) en tratamiento
2) Esofagitis grado C de los angeles
3) HTA
4) TBQ suspendido
5) OH suspendido

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J47.X-BRONQUIECTASIA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

paciente consulta el 03/04 por cuadro de 4 dias de evolucion de tos productiva, hemoptisis, rinorrea acuosa. se solicita TAC de torax, donde se evidencia bronquiectasias en lobulo superior izquierdo, con contenido denso y adenopatia mediastinicas reactivas. Examenes de lab al ingreso crea 0,5; PCR 62; Na/K/140/3.4; Hb 10,2; Gb 11,5.
Se decide ingreso apra estudio
Evaluado por broncopulmonar, donde se decide realizacion de fibrobroncoscopia el 09/04, se describe bronquio LSI sangrado en napa desde segmento apico posteiror, bronquio para LII sin sangrado, sin secreciones, se maneja sangrado con suero y adrenalina topica, lavado en segmento apico posteiror de LSI, se toma muestra para genXpert y cultivo.

Paciente actualmente HDN estable, afebril, sin episodios de nauseas y/o vomitos, con buena tolerancia a alimentacion VO, bronquiectasias al interrogatorio dirigido en franca disminucion. Acorde a videobroncoscopia, se describe leve sangramiento en napa. PCR tuberculosis BD max no detectado, genXpert no detectado

Ex de lab 14/04 -> crea 0,6; LDH 126; lactato 0,9; PCR 13,9; Na/k/Cl 135/4.7/98; Hb/Hcto 11/33.6; Gb 9,4; plaq 421000; segment 58%;
Cultivo broncoalveolar (-)

Ex fisico -> Vigil, CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs, se visualiza en encias gingivorragia escasa
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventialtorio. Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Con cultivo broncoalviolar (-), se derivada a HODOm para conniuar con 14 dias de terapia ATB
4) Cirugia: Pendiente continuar

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen liviano a tolerancia
3. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 2 dias
4. Bromuro re ipratropio 2 puff c/6hrs por AC por 5 dias
5. Mulcatel 10 cc c/8hrs VO por 5 dias
6. metamizol 300 mg c/8hrs por 5 dias VO
7. paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hr VO por 5 dias
8. KNT motora y respiratoria dos veces al dia
9. CSV c/8 hrs
10. Examenes de control 17/04
11. Pendiente rescate de US de EESS

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO